



Plan de encuestas de satisfacción del CatSalut-PLAENSA®. Estrategias para incorporar la percepción de la calidad de servicio de los ciudadanos en las políticas de salud

Hortensia Aguado-Blázquez^{a,*}, Ismael Cerdà-Calafat^a, Josep Maria Argimon-Pallàs^b, Carles Murillo-Fort^c y Jaume Canela-Soler^{d,e,f}

^aDivisió d'Atenció Ciutadana, Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, España

^bGerència de Compra i Avaluació de Serveis Assistencials, Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, España

^cCentre de Recerca en Economia i Salut, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España

^dDirecció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, España

^eDepartament de Salut Pública, Universitat de Barcelona, Barcelona, España

^fDepartment of Epidemiology and Biostatistics, College of Public Health, University of South Florida, Tampa, Florida, Estados Unidos

RESUMEN

Palabras clave:

Opinión
Satisfacción
Indicadores de calidad
Ciudadano
Mejora

El objetivo de este artículo es presentar las estrategias, actividades y resultados del Plan de encuestas de satisfacción del CatSalut-PLAENSA® 2003-2010, que están facilitando avanzar en la mejora de la calidad de los servicios sanitarios. Desde 2003 se dispone del Plan de encuestas de satisfacción PLAENSA®, una herramienta de evaluación y de propuesta de mejora de los servicios que presta la aseguradora pública a través de las entidades proveedoras contratadas siguiendo 3 estrategias clave: medir sistemática y objetivamente la satisfacción de los asegurados con los servicios recibidos; elaborar propuestas de mejora acorde con un modelo sistematizado y normalizado con actividades de seguimiento, y fomentar la equidad mediante la diseminación en los centros sanitarios y territorios. Actualmente se dispone de la valoración de los asegurados de la mayor parte de servicios sanitarios, con más de 2.500 proyectos de mejora en funcionamiento en los distintos proveedores de las 7 regiones sanitarias de Cataluña.

© 2011 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Satisfaction survey of CatSalut-PLAENSA®. Strategies to incorporate citizens' perception of the quality of the service in health policies

ABSTRACT

Keywords:

Opinion
Satisfaction
Quality indicator
Citizenship
Improvement

The aim of this work is to present the strategies, activities and results of satisfaction surveys Plan CatSalut-PLAENSA® 2003-2010 that are making progress in improving the quality of health services. Since 2003, CatSalut has at its disposal the plan known as PLAENSA® Satisfaction Surveys, a tool for assessment and improvement proposals addressed to the insurance services provided by contracted public entities. The plan follows 3 key strategies: systematic and objective policyholders' satisfaction measurement, related to the services received; release of improvement proposals according to a standardized model, including standardized monitoring, and promotion of equity through propagation among health centres and territories. Current assessment provided by the insured about most health services has been already collected, leading to more than 2,500 projects of improvement which are being developed by the providers of the 7 health regions of Catalonia.

© 2011 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

El Servei Català de la Salut (CatSalut) es el ente público adscrito al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que garantiza las prestaciones sanitarias de Cataluña. Su misión es garantizar una

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: haguado@catsalut.cat (H. Aguado-Blázquez).

	2003-2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Atención primaria	•		•			•			•
Atención hospitalaria con internamiento	•		•			•			•
Atención sociosanitaria con internamiento	•			•			•		
Atención a la salud mental ambulatoria	•		•			•			•
Atención a la salud mental con internamiento	•			•			•		
Atención hospitalaria urgente		•			•			•	
Atención especializada ambulatoria					•			•	
Transporte sanitario no urgente						•			•
Receta electrónica							•		
Embarazo, parto, puerperio							•		

Figura 1. Planificación del Plan de encuestas de satisfacción del CatSalut. Fuente: Servei Català de la Salut-PLAENSA®.

atención sanitaria de calidad mediante una adecuada adaptación de la oferta sanitaria a las necesidades de los asegurados^{1,2}.

De acuerdo con las teorías sociológicas más aceptadas^{3,4}, el nivel de satisfacción con los servicios sanitarios está claramente relacionado con el grado de adecuación entre las expectativas depositadas a priori y la percepción final del servicio recibido por parte de los usuarios.

La opinión expresada por la ciudadanía ofrece una información esencial para conocer el funcionamiento de los servicios sanitarios y constituye un instrumento de participación en la mejora de la calidad de la asistencia, ayudando a los organismos reguladores, comunidades autónomas y gobierno central, a proveer servicios más eficientes y adecuados a las necesidades expresadas.

El Plan de encuestas de satisfacción de asegurados del CatSalut (PLAENSA®) que se inicia el ejercicio de 2001, y se enmarca en este contexto, ha resultado innovador tanto por el alcance que se proponía como por su contenido, permitiendo al CatSalut disponer del conocimiento necesario para avanzar en una de sus líneas estratégicas prioritarias: orientar a las organizaciones sanitarias a las necesidades y expectativas de los asegurados. La figura 1 muestra la planificación del plan de encuestas, en la que aparecen los estudios realizados y los previstos desde 2002 hasta 2012.

El análisis de los resultados de las diferentes ediciones del PLAENSA® sirve para conocer las áreas de excelencia y de mejora, así como para proponer periódicamente las actuaciones que se deben llevar a cabo en los distintos niveles y servicios sanitarios. A su vez, la sistemática de trabajo propuesta (fig. 2) permite avanzar en la interiorización del modelo de mejora continua de la calidad PDCA (acrónimo de *plan, do, check, act* “planificar, hacer, verificar, actuar”) en todo el sistema sanitario, mediante un proceso progresivo de implantación, diseminación y aprendizaje que queda incorporado en el contrato anual que se realiza entre la aseguradora pública y las entidades proveedoras.

Objetivos

Presentar las estrategias, las actividades y los resultados del Plan de encuestas de satisfacción del CatSalut-PLAENSA® 2003-2010 que están facilitando avanzar en la mejora de la calidad de los servicios sanitarios mediante la incorporación de la voz de la ciudadanía y que se concretan en:

- Diseñar herramientas válidas que proporcionen datos objetivos de la valoración que realizan los asegurados sobre los servicios de salud recibidos.
- Incorporar de forma consensuada un modelo contractual con los responsables territoriales y los proveedores que agregue los temas prioritarios de la ciudadanía como eje de los proyectos de mejora futuros.

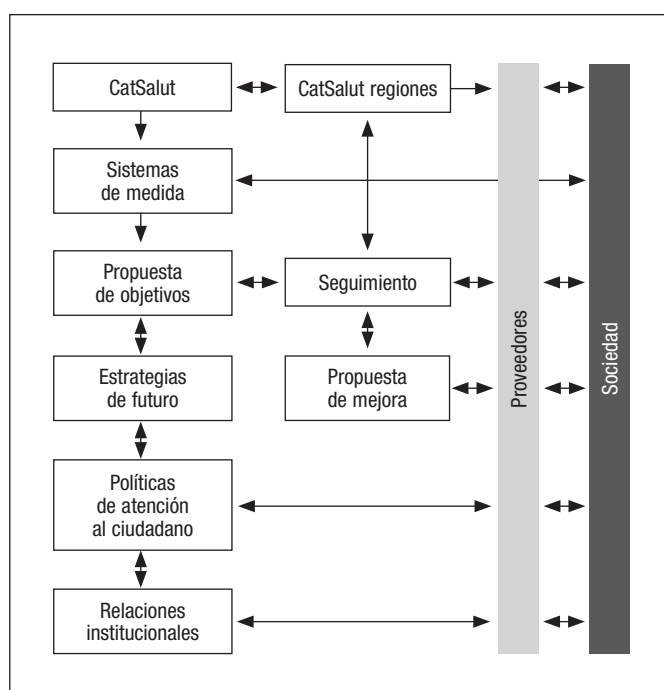


Figura 2. El modelo de trabajo para la mejora del CatSalut. Fuente: Servei Català de la Salut-PLAENSA®.

- Implantar líneas estratégicas para fomentar la equidad territorial basadas en la opinión de la los asegurados.

Material y métodos

El proyecto se sustenta en 3 ejes principales: medir la satisfacción, mejorar la prestación de servicios y diseminar el modelo.

Diseño: desarrollo del PLAENSA® y recogida de datos

El PLAENSA® presenta un diseño metodológico riguroso⁵⁻⁷ que se ha mantenido hasta hoy en día con pautas comunes para todas las líneas de atención estudiadas y que está acompañado de estrategias orientadas a conseguir el consenso en el sector y la comunicación permanente del proyecto a todos los grupos de interés. El estudio de cada línea de servicio se desarrolla en 3 fases: diseño, realización y comunicación (fig. 3).

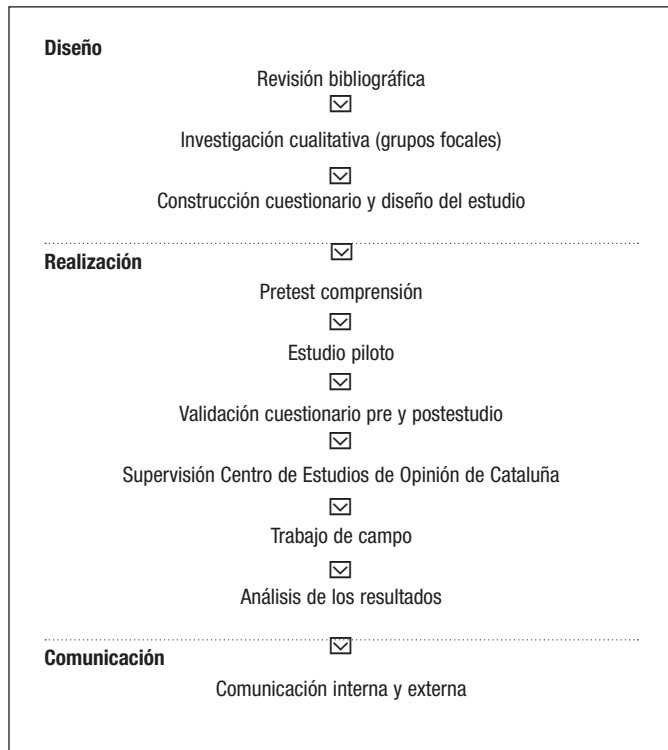


Figura 3. Metodología. Fuente: Servei Català de la Salut-PLAENSA®.

En la etapa de diseño se crean los instrumentos adecuados para concretar las dimensiones⁸ que conforman la valoración de la satisfacción y de la calidad del servicio. Partiendo de una revisión bibliográfica y de una consulta a profesionales y a organismos nacionales e internacionales, así como de la búsqueda de otros instrumentos y experiencias, se definen los principales factores que representan la satisfacción^{9,10} teniendo en cuenta las variables socioculturales que caracterizan a los individuos que frecuentan cada una de las diferentes líneas de servicio. Seguidamente, se identifican las áreas de interés de los asegurados a través de un análisis cualitativo¹¹ que incluye técnicas como grupos focales y entrevistas. Estas técnicas exploratorias representan uno de los puntos fuertes de la investigación llevada a cabo por el CatSalut, las cuales ayudan a definir las características del cuestionario final^{12,13} que, con previa validación estadística, garantiza su fiabilidad y su validez para el uso periódico¹⁴⁻¹⁶ y que permite posteriormente cuantificar los resultados.

La fase de realización comprende la planificación y ejecución del trabajo de campo, que permite la obtención de resultados objetivos, fiables y válidos a través de técnicas cuantitativas. Una vez se ha concretado la población diana (asegurados del CatSalut atendidos en Cataluña por las diferentes líneas de servicio) y la población de estudio seleccionada mediante criterios de exclusión e inclusión, se realiza el cálculo del tamaño de la muestra una vez fijados los criterios estadísticos relativos al nivel de confianza; los objetivos de la inferencia y la potencia de los contrastes posteriormente realizados, y la selección de casos a entrevistar^{17,18}. A continuación se desarrolla el trabajo de campo de recogida de información mediante encuestas telefónicas o presenciales. Una vez se dispone de la información, se lleva a cabo el análisis de los resultados por cada línea de servicio y/o producto.

Finalmente, la etapa de comunicación cierra el proceso de medida con la publicación¹⁹ de los resultados en 2 etapas: una previa relacionada con los objetivos, los plazos del estudio y los resultados esperados y una segunda etapa de información y comunicación de los resultados obtenidos y propuestas de mejora dirigidas al Departament de Salut;

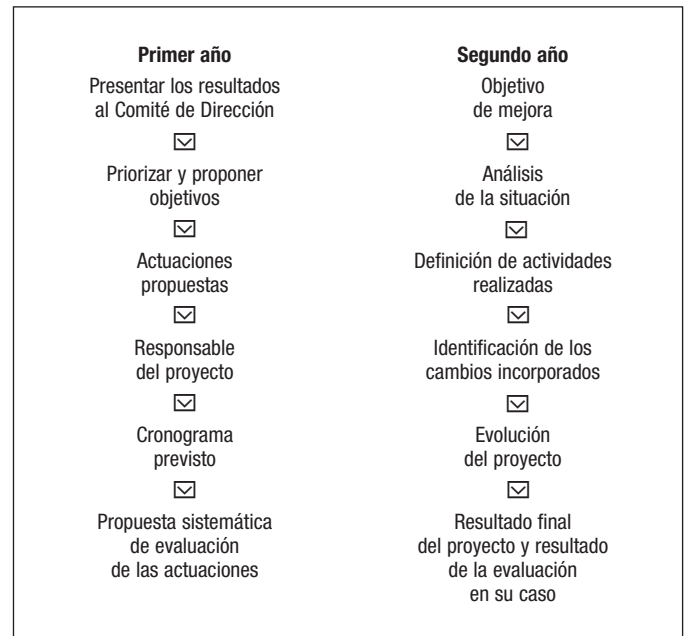


Figura 4. Informe normalizado de autoevaluación. Fuente: Servei Català de la Salut-PLAENSA®.

mento de Salut; a los responsables territoriales del CatSalut y a sus proveedores; al Instituto Catalán de la Salud; al Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña; a las patronales sanitarias y a los representantes sociales en el marco de los consejos de dirección donde están representados, así como a la ciudadanía en general, en un ejercicio de transparencia.

Actuaciones de mejora: los proyectos

El proyecto ha ido acompañado desde el inicio de un documento normalizado de autoevaluación, consensuado con expertos en metodología cualitativa que sirve de guía tanto al comprador como al proveedor (fig. 4). El factor diferencial respecto a otros sistemas de mejora es que la taxonomía implantada no pretende medir el éxito o el fracaso de la actuación sino que, por el contrario, identifica que las actuaciones hayan sido realizadas. Este cambio de paradigma permite la aceptación, por parte de los proveedores, de la incorporación de una parte variable en el contrato de servicios con el CatSalut²⁰, que queda sometida a estos resultados. El CatSalut, además, asume un papel de verificador realizando un seguimiento de las actividades que se proponen para fomentar el papel activo de los proveedores, puesto que lo que se incentiva es la cultura de la mejora continua^{21,22} y no su éxito o su fracaso. En el documento de trabajo normalizado debe quedar constancia de la valoración de los resultados de la encuesta de satisfacción por parte de los responsables del centro; la inclusión de los objetivos previstos; las actuaciones propuestas y los responsables de las actuaciones; el cronograma de las intervenciones, así como una valoración de la/las actuación/es desarrollada/as.

Diseminación del modelo: equidad territorial

Las propuestas de los proyectos o planes de mejora de la calidad percibida se basan en una sistemática de trabajo que va de los servicios centrales a las unidades territoriales proveedoras, implicándolos de manera transversal, tanto en el ámbito de las regiones sanitarias como de los proveedores. Esta propuesta está orientada a conseguir la implantación y diseminación de un modelo de mejora continua de la calidad que, liderado por el CatSalut, llega a través de los respon-

Tabla 1
Satisfacción global de los encuestados (escala de 0 a 10) y fidelidad

	Año	Satisfacción	Fidelidad, %
Atención primaria	2003	7,7 ± 1,7	86,3
	2006	7,6 ± 1,6	88,9
	2009	7,6 ± 1,6	87,4
Atención hospitalaria	2003	8,6 ± 1,6	91,8
	2006	8,2 ± 1,7	88,4
	2009	8,3 ± 1,8	89,8
Atención sociosanitaria	2003	8,3 ± 1,8	78,4
	2007	8,2 ± 1,7	83,1
	2010	8,2 ± 1,5	91,7
Atención psiquiátrica y salud mental Ambulatoria	2003	7,8 ± 2	82,9
	2006	7,6 ± 2	83,7
	2009	7,7 ± 2	83,8
Con internamiento	2003	7,5 ± 2,5	66,6
	2007	7,3 ± 2,4	63
Atención en urgencias	2006	7,3 ± 7,2	82,2
	2008	7,3 ± 7,2	80,2
	2008	7,5 ± 1,8	83,1
Atención en consultas externas	2009	8,6 ± 1,7	90,1
Transporte sanitario no urgente	2010	8,5 ± 1,8	
Receta electrónica	2010	8,0 ± 1,5	85
Embarazo, parto y puerperio	2010		

Fuente y elaboración: Servei Català de la Salut-PLAENSA®.

sables territoriales a la ciudadanía receptora de los servicios y, por tanto, de los proyectos de mejora (fig. 2).

Finalizado el proceso de mejora, los resultados se hacen llegar en primer lugar a los responsables territoriales y a las entidades proveedoras para, a continuación, hacerlo accesible a través de la web corporativa^{23,24}. Asimismo, se incluye en la memoria anual del CatSalut el número total de actuaciones de mejora propuestas y el porcentaje conseguido por línea de servicio y territorio.

Resultados

En cuanto a la medida, el resultado principal que el CatSalut ha alcanzado es el conocimiento periódico de la opinión de la ciudadanía mediante herramientas validadas y contrastadas metodológicamente, consiguiendo disponer permanentemente de la información de la mayoría de servicios contratados²⁵⁻²⁷.

Gracias al PLAENSA®, en el que se ha encuestado a más de 150.000 personas, se dispone de los resultados de satisfacción y calidad per-

cibida en las líneas de: atención primaria; atención hospitalaria de agudos; atención sociosanitaria con ingreso; atención psiquiátrica y de salud mental ambulatoria y con ingreso de media y larga estancia; atención urgente hospitalaria; atención especializada ambulatoria, transporte sanitario no urgente, receta electrónica y embarazo, parto y puerperio. Como valor añadido, el PLAENSA® proporciona a los centros sanitarios la información necesaria para la obtención de la acreditación de centros sanitarios en Cataluña, especialmente la que se refiere a los procesos de gestión y mejora de las relaciones con los clientes. La tabla 1 ilustra la satisfacción global de los encuestados (en una escala de 0 al 10) y el porcentaje de los que volverían al centro sanitario en cada línea de servicio por cada línea estudiada.

En cuanto a la mejora, la incorporación de la voz del ciudadano en los objetivos de los contratos de compra de servicios del CatSalut²⁴ queda constatada por los 2.500 proyectos de mejora realizados en los últimos 5 años en los que se representan los valores institucionales del CatSalut, puesto que las propuestas de mejora se realizan en las áreas propuestas por la ciudadanía.

Las 950 unidades proveedoras implicadas han demostrado un compromiso con la cultura de mejora continua de la calidad²⁸, de la cual es promotor el CatSalut, en un entorno de diálogo constructivo y de participación de todos²⁹ en beneficio de la sociedad. La figura 5 muestra las actuaciones de mejora agrupadas por línea de servicio durante los años 2005-2006 y 2007-2008 y en ella se puede observar el incremento de actividades por cada línea.

En cuanto al alcance de la equidad y adecuación territorial conseguida con la diseminación del modelo, además de las más de 50 sesiones de trabajo en los diferentes territorios y el seguimiento específico y continuado de las propuestas de mejora de cada proveedor, se realiza anualmente una sesión corporativa de seguimiento de objetivos de calidad percibida, con un formato estándar de jornada, en la que se presentan por parte del CatSalut los resultados de los estudios realizados y de las actuaciones tanto por líneas de servicio como a nivel de territorio, con la finalidad de poner en común las experiencias y sistemáticas aplicadas. En las sesiones realizadas desde 2005 a 2010 y con una asistencia media por sesión de 250 profesionales de la sanidad catalana, se han compartido aportaciones de expertos en cuestiones relacionadas con la calidad, declaraciones del mundo académico sobre temas metodológicos de interés e intervenciones institucionales de la realidad sanitaria como las del Departamento de Salud, la Generalitat de Catalunya, las patronales sanitarias, los profesionales asistenciales y los gestores sanitarios. También se han expuesto actuaciones de mejora desarrolladas por parte de proveedo-

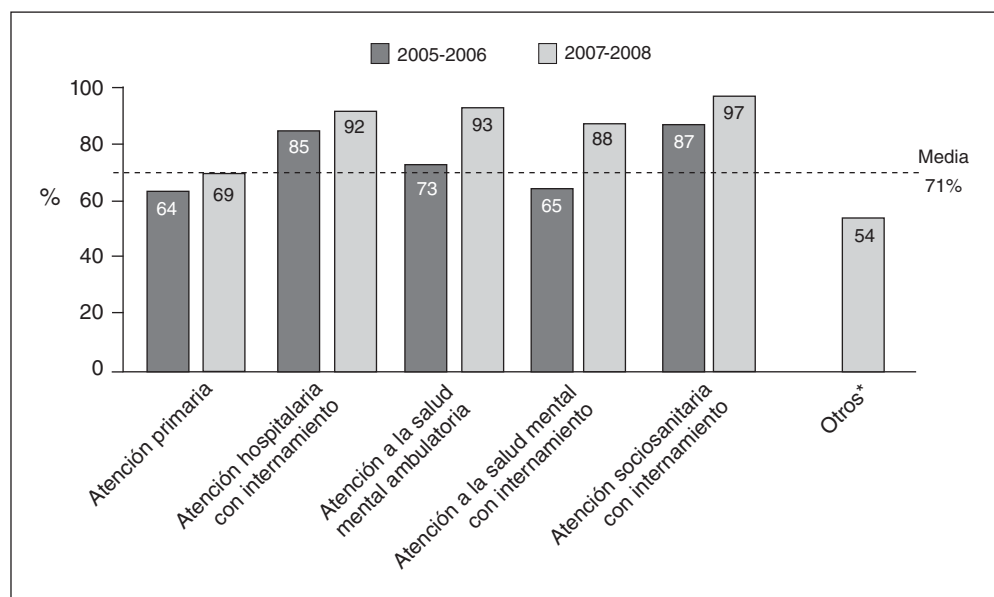


Figura 5. Actuaciones de mejora por línea de servicio, 2005-2006 y 2007-2008. Fuente: Servei Català de la Salut-PLAENSA®.

res, que han sido consideradas de interés por su novedad, por ser representativas de un territorio o ser referente en su entorno.

Discusión

La razón de ser de un sistema de salud universalista es intentar mantener y mejorar la salud de toda la población y que quienes lo necesiten dispongan de la mejor atención sanitaria posible. Es por ello que tiene un gran significado el diálogo entre la Administración y los administrados, las instituciones y la ciudadanía, los profesionales y los usuarios³⁰. Es a partir de estas premisas que tiene sentido el proyecto realizado y el compromiso de futuro del CatSalut en la atención a la ciudadanía en el ámbito de la salud. Con todo ello, el CatSalut ha definido un modelo de mejora de la calidad percibida que pretende dar como resultado a medio plazo el establecimiento de un patrón de actuación común a todos los actores del sistema sanitario público y, a la vez, servir como referencia para la sanidad privada.

El éxito obtenido radica en su rigor metodológico, pero sobre todo en su proximidad a los intereses de la ciudadanía. Los estudios del PLAENSA[®] proporcionan a los centros sanitarios la información necesaria sobre la calidad de los servicios sanitarios³¹, aspectos clave en los que se deben basar las estrategias y los procesos de gestión con el objetivo final de mejorar las relaciones con sus usuarios. Por otro lado, la información específica que el CatSalut ofrece periódicamente a cada proveedor sanitario hace innecesarios la mayoría de los estudios propios que los centros sanitarios realizaban, además de permitir la comparación objetiva con relación a Cataluña y a sus regiones sanitarias.

Puesto que la salud se entiende cada vez más como un concepto integral, deberán identificarse de manera transversal los diferentes puntos del itinerario de salud que sigue el ciudadano en el sistema sanitario, más allá de las estructuras clásicas de atención, como un proceso continuo ligado a situaciones de salud: el reto es un cambio de paradigma hacia una visión transversal "continuum asistencial".

En este sentido, la apuesta decidida del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación fomentará que la ciudadanía pueda interactuar en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel estratégico³² como operativo en relación con los servicios de salud. A ello se añade el seguimiento de la información que circula por internet y las redes sociales como un espacio preferente para recoger las opiniones y expectativas de los individuos.

En una sociedad como la que configura nuestro entorno más cercano, sometida a cambios continuos, parece recomendable impulsar la revisión periódica del diseño estratégico así como de los métodos empleados para alcanzar los objetivos propuestos. Las variaciones en el entorno desencadenan también cambios en las expectativas y percepciones de los asegurados y, en definitiva, en la relación entre las necesidades expresadas y los servicios ofertados. En este proceso debe tenerse en cuenta de forma organizada la opinión de los individuos, de los profesionales sanitarios, de los responsables de la definición de los planes de salud en todas y cada una de las fases del PLAENSA[®]. De este modo se establecen las condiciones para garantizar que tanto los instrumentos de medida de la satisfacción como las propuestas de mejora de la prestación sanitaria y la diseminación del modelo están de acuerdo con las exigencias de los diferentes grupos de interés.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Aguado H, Artigas M, Agusti E, Saura RM, Ribalta A, Suñol L. Pla d'enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut. *Annals de Medicina*. 2005;88:98-100.
- Servei Català de la Salut. Coneix el CatSalut [consultado 22-12-2010]. Disponible en: <http://www10.gencat.net/catsalut/cat/coneix.htm>
- Mira JJ, Rodríguez-Marín J, Tirado S, Sitges E. Semejanzas y diferencias entre satisfacción y calidad percibida. *Rev Calidad Asistencial*. 2000;15:36-42.
- De Ruyter K, Bloemer J, Peeters P. Merging service quality and service satisfaction. An empirical test of an integrative model. *Economic Psychol*. 1997;18:387-406.
- Dawn AG, Lee PP. Patient satisfaction instruments used at academic medical centers: results of a survey. *Am J Med Qual*. 2003;18:265-9.
- Díaz R. La calidad percibida en la sanidad pública. *Rev Calidad Asistencial*. 2005;20:35-42.
- Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud. Atención Primaria de Salud. Encuestas de satisfacción (2008) [consultado 22-12-2010]. Disponible en: <http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/indicadores/default.asp?tpcentro=ap&provincia=Todas&periodo=2008>
- Servicio Catalán de la Salud - CatSalut. Plan de encuestas de satisfacción de asegurados del CatSalut por línea de servicio (atención primaria, hospitalaria, sociosanitaria y salud mental). Metodología General 2003 [consultado 22-12-2010]. Barcelona: División de Atención al Cliente y Área de Servicios y Calidad Asistencial. Disponible en: http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/enquesta_metodologia_castella.pdf
- Palacio Lapuente F, Marquet Palomar R, Oliver Esteve A, Castro Guardiola P, Bel Reverter M, Castro P, et al. Las expectativas de los pacientes: ¿qué aspectos valoran en un centro de salud? Un estudio cualitativo. *Aten Primaria*. 2003;31:307-14.
- Valera J, Rial A, García E. Presentación de una escala de satisfacción con los servicios sanitarios de atención primaria. *Psicothema*. 2003;15:656-6.
- Gil F, Barrasa A, Roda R. Grupos de discusión. En: Gil F, Alcover CM. Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Pirámide; 2004.
- Kelley K, Clark B, Brown V, Sitzia J. Good practice in the conduct and reporting of a survey research. *Int J Qual Health Care*. 2003;15:261-6.
- Servicio Catalán de la Salud - CatSalut. Plan de encuestas de satisfacción de asegurados del CatSalut por línea de servicio (atención primaria, hospitalaria, sociosanitaria y salud mental). Metodología General 2003 [consultado 22-12-2010]. Barcelona: División de Atención al Cliente y Área de Servicios y Calidad Asistencial. Disponible en: http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/enquesta_metodologia_castella.pdf
- Alonso R, Blanco-Ramos MA, Gayoso P. Validación de un cuestionario de calidad de cuidados de enfermería. *Rev Calidad Asistencial*. 2005;20:246-50.
- González N, Quintana JM, Bilbao A, Escobar A, Aizpuru F, Thompson A, et al. Development and validation of an in-patient satisfaction questionnaire. *Int J Qual Health Care*. 2005;17:465-72.
- Yavas U, Shemwell DJ. Modified importance-performance analysis: an application to hospitals. *Int J Qual Health Care*. 2001;14:104-10.
- Haddad S, Potvin L, Roberge D, Pineault R, Remondin M. Patient perception of quality following a visit to a doctor in a primary care unit. *Fam Pract*. 2000;17:21-9.
- Murillo C. Dictamen relatiu a l'enquesta de satisfacció del CatSalut 2005, 2006, 2007, 2008. Document intern. Divisió d'Atenció al Ciutadà. CatSalut.
- Aguado H. La voz de la ciudadanía. Cómo la percepción de la ciudadanía se vincula a la mejora de los servicios sanitarios y el sistema de salud de Cataluña [consultado 22-12-2010]. Barcelona: Departament de Salut, Servei Català de la Salut. Disponible en: http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/publicacions/veu_ciudadania_plaensa_castella.pdf
- Argimon JM, Brosa F, Casas C, Agustí E. Smart Purchasing—Selektives Kontrahieren in Spanien. En: Amelung VE, Deimel D, Reuter W, Van Rooij N, Weatherly JN, editors. *Managed Care in Europa*. Berlin: MWV; 2009. p. 205-18.
- Kelley K, Clark B, Brown V, Siriza J. Good practice in the conduct and reporting of a survey research. *International Journal for Quality in Health Care*. 2003;15:261-6.
- Krogstad U, Hofoss D, Hjortdahl P. Doctor and nurse perception of inter-professional co-operation in hospitals. *Int J Qual Health Care*. 2004;16:491-7.
- Servei Català de la Salut. Taula resum. Millora de la qualitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris a Catalunya. Estudis realitzats i estudis previstos [consultado 22-12-2010]. Disponible en: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/prov_enquestes_tau-la.htm
- Servei Català de la Salut. Memòries d'activitat. Instrument d'informació i comunicació de les activitats anuals del CatSalut, les regions sanitàries i les empreses públiques [consultado 22-12-2010]. Disponible en: http://www10.gencat.net/catsalut/cat/publicacions_memories.htm
- Mira JJ, Aranzaga J. La satisfacción del paciente como una medida del resultado de la atención sanitaria. *Med Clin (Barc)*. 2000;114:26-33.
- Riba C, Cuxart A. Construyendo las bases para una comparación fiable: la Encuesta Social Europea 2002 en España. *Revista Española de Ciencia Política*. 2003;8:165-85.
- Monteagudo O, Navarro C, Alonso P, Casas R, Rodríguez L, García J, et al. Aplicación hospitalaria del SERVQHOS: factores asociados a la satisfacción e insatisfacción. *Rev Calidad Asistencial*. 2003;18:263-71.
- Sánchez E, Letona J, González R, García M, Darpón J, Garay JL. A descriptive study of the implementation of the EFQM excellence model and underlying tools in the Basque Health Service. *Int J Qual Health Care*. 2006;18:58-65.
- Pujol Ribera E, Gené Badía J, Sans Corrales M, Sampietro-Colom L, Pasarín Rua MI, Iglesias-Pérez B, et al. El producto de la atención primaria definido por profesionales y usuarios. *Gac Sanit*. 2006;20:209-19.
- Berwick DM. Continuous improvement as an ideal in health care. *N Engl J Med*. 1989;320:53-6.
- Abalo Piñeiro I, Varela Mallou J, Rial Boubeta A. El análisis de importancia-valoración aplicado a la gestión de servicios. *Psicothema*. 2006;18:730-7.
- Cerdà-Calafat I, Contínente-Gonzalo M, García-López C, Guanyabens-Calvet J. Carpeta Personal de Salud. *Med Clin (Barc)*. 2010;134 Supl 1:63-6.